

TEMA 36



LA RED DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID: CIRCUITO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

CRITERIOS Y METODOLOGÍA PARA LA ATENCIÓN SOCIAL.

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- La red de Atención Social Primaria del Ayuntamiento de Madrid.	
2.- Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales.	
2.1.- Marco de referencia de los Centros de Servicios Sociales. 2.2.- Contenido de los Centros de Servicios Sociales. 2.3.- Funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales.	
3.- Circuito de atención al ciudadano en los Centros de Servicios Sociales.	
3.1.- El modelo de atención primaria para los Servicios Sociales Generales. 3.2.- El circuito de atención al ciudadano, 3.3.- Funciones generales de los profesionales de las Unidades de Trabajo Social.	
4.- Criterios para la atención social.	
4.1.- Criterios organizativos de la atención en horario de mañana.	
5.- Metodología para la atención social.	
5.1.- Criterios generales de intervención para la Primera Atención. 5.2.- Criterios generales para la intervención en Unidades de Trabajo Social de Zona. 5.3.- La atención de las urgencias sociales. 5.4.- Atención social desde la Unidad de Programas. 5.5.- Atención social a menores.	
6.- Plan de Atención Social Primaria.	
6.1.- Introducción. 6.2.- Visión del futuro de la atención social primaria. 6.3.- Misión de la atención social primaria. 6.4.- Objetivos de la atención social primaria. 6.5.- Estrategias y Programas del Plan de Atención Social Primaria.	
7.- Plan de Mejora de la Atención Social Primaria.	
7.1.- Diagnóstico de situación del modelo organizativo de los Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid. 7.2.- Propuesta de mejora. 7.3.- Áreas de mejora.	
8.- Instrucción 1/2.018 sobre la organización de la atención en los Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid.	

0.- INTRODUCCIÓN.

El Ayuntamiento de Madrid, como Administración responsable de la **atención social al ciudadano**, emprendió en el año 1.996 un proceso de mejora del sistema de Atención Social Primaria, que tenía como meta **incrementar la calidad de la atención a los ciudadanos.**

La aprobación y puesta en marcha del **Plan de Atención Social Primaria 2.008-2.011**, partiendo de un análisis de la realidad crítico y amplio, define cuatro líneas estratégicas que buscan completar la apuesta por un sistema de Servicios Sociales que pueda garantizar y promover a los ciudadanos madrileños sus derechos sociales.

La **Carta de Servicios de los Centros de Servicios Sociales,** aprobada el mes de julio del 2.010, completa el compromiso institucional de nuestro municipio por el Sistema de Servicios de Atención Social Primaria, conjugando la cobertura de las necesidades sociales con la calidad de estas respuestas.

Queda ya lejos el **Reglamento de Organización y Funcionamiento de Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid** de 1.989. Aunque el Reglamento sigue vigente, las nuevas necesidades sociales y el crecimiento de los recursos los cambios en el sistema de Servicios Sociales han sido numerosos y profundos.

En la organización de los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de Madrid confluyen dos estructuras diferentes:

- La primera se caracteriza por su **carácter centralizado**, y se ubica en el **Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad (**concretamente desde la **Dirección General de Servicios Sociales y Atención a la Discapacidd).** Su finalidad es la cohesión social de la ciudad de Madrid a través de la prestación de servicios personales destinados a garantizar el bienestar de todos los ciudadanos, previniendo situaciones de marginalidad y exclusión social.
- La segunda estructura se centra en la **descentralización territorial**, garantizando la cercanía de los Servicios Sociales a los ciudadanos. Las **Juntas Municipales de Distrito** a través del **Departamento de Servicios Sociales** asume esta responsabilidad. De este Departamento dependen los **Centros Municipales de Servicios Sociales.**

Resumiendo, el desarrollo de la Atención Social Primaria en el Ayuntamiento de Madrid ha sido planteado desde una serie de documentos que han ido configurando la red municipal de Centros de Servicios Sociales:

- Aun estando en vigor la primera Ley de Servicios Sociales (Ley 11/1.984), se elaboró el **Reglamento de Organización y Funcionamiento de Centros de Servicios Sociales del año 1.989.**
- La atención a los ciudadanos se basa en el **Modelo de Atención**, aprobado en **1.998**.
- En el año 2.008 la entonces Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales aprobó el **I Plan de Atención Social Primaria (2.008-2.011).**
- En el año 2.010 se aprobó la **Carta de Servicios de los Centros de Servicios Sociales.**

1.- LA RED DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

En el Ayuntamiento de Madrid, para el cumplimiento de sus competencias y funciones referidas a la Atención Social Primaria, existe una **estructura central**, con competencias de planificación y coordinación delegadas en el **Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad**, y una **estructura descentralizada** a nivel territorial, en los **21 distritos del municipio**, destinada a cumplir el objetivo de los Servicios Sociales de ser accesibles y cercanos a los entornos de vida y convivencia de los ciudadanos. Este objetivo de cercanía se lleva a cabo a través de los Departamentos de Servicios Sociales que forman parte de la estructura organizativa de los Distritos, y en los que se ubican los Centros de Servicios Sociales.

En el Anexo, desarrollamos los datos ofrecidos en la **MEMORIA DEL 2.022** sobre la red de Atención Social Primaria del Ayuntamiento de Madrid.

Las **prestaciones y recursos** que se ofrecen en el Centros de Servicios Sociales son principalmente los siguientes:

1.-	**Información y orientación sobre Servicios Sociales y otros sistemas de protección social**. ▪ Acoger a la persona o personas que hacen la demanda. ▪ Informar a las personas, de manera individual o en grupos dirigidos, sobre sus derechos y las prestaciones que existen y sobre los requisitos necesarios para el acceso a los mismos. ▪ Realizar la valoración inicial de la demanda de tipo individual, familiar o grupal. ▪ Detectar otras situaciones de necesidad de las personas usuarias. ▪ Orientar sobre opciones y alternativas disponibles para responder a la demanda planteada. ▪ Facilitar el acceso a otros servicios cuando proceda.
2.-	**Asesoramiento social.** ▪ Valorar la demanda planteada aplicando baremos y otros instrumentos de valoración, teniendo en cuenta las circunstancias personales, familiares y sociales de cada persona. ▪ Proponer alternativas de actuación según la valoración realizada y teniendo en cuenta los recursos disponibles. ▪ Ofrecer apoyo profesional en la toma de decisiones en relación con las actuaciones propuestas.
3.-	**Apoyo social y seguimiento.** ▪ Valorar las necesidades y problemas identificados, elaborando el correspondiente diagnóstico social. ▪ Diseñar, de acuerdo con la persona o familia, un **programa de intervención** para cada caso particular. ▪ Poner en marcha el programa de intervención para responder a las necesidades y problemas identificados, por medio del acompañamiento social y la asignación de servicios y recursos sociales disponibles. ▪ Establecer coordinación con otros profesionales y servicios relacionados con el programa de intervención.

	▪ Proporcionar atención continuada, tanto individual como familiar y grupal, por parte de la/el trabajadora/or social evaluando periódicamente el programa de intervención.
4.-	**Atención de situaciones de desprotección social.** ▪ Hacer una valoración inicial del grado de riesgo y de la urgencia de la situación. Se consideran supuestos de urgencia: - Agresiones o malos tratos, manifiestos o no, a cualquier persona. - Abandonos por acontecimientos sobrevenidos que conllevan la pérdida de apoyo en personas que carecen de recursos personales y/o familiares que les sitúa en una posición de grave vulnerabilidad. - Perdida inminente de alojamiento/vivienda: situaciones de desahucios, perdida de vivienda o demoliciones no previstas o desconocidas previamente por servicios sociales. - Situaciones de desprotección social relacionadas con problemas de salud de personas con falta de autonomía personal, sin apoyo familiar suficiente y escasez de recursos económicos. - Situaciones de desprotección sociofamiliar derivadas de Emergencias. Situaciones previamente atendidas por los Servicios de Emergencia que facilitaran información concreta del hecho y la actuación realizada.
5.-	**Gestión de servicios y ayudas sociales.** ▪ Valorar técnicamente la situación de la persona y plantear, teniendo en cuenta su opinión, los servicios y ayudas sociales disponibles. ▪ Tramitar los servicios y ayudas sociales del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid, de otras Administraciones y de otras entidades de la iniciativa social, de acuerdo con el programa de intervención. ▪ Proponer la concesión, cuando proceda, del servicio o ayuda municipal correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles. ▪ Realizar el seguimiento de los servicios y las ayudas sociales para asegurar su correcto uso o aplicación y su adecuación a la necesidad valorada. ▪ Apoyar técnicamente aquellos proyectos de la Iniciativa Social y/o de Entidades Privadas con los que el Ayuntamiento de Madrid ha establecido convenios de colaboración.

NOTA. La Carta de Servicios de los Centros de Servicios Sociales se desarrolla en el Tema 69).

2.- REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

El **Reglamento** fue aprobado por Acuerdo Plenario de 22 de junio de 1.989, entrando en vigor el 14 de septiembre de ese mismo año. Este documento aún se mantiene en vigor, aunque la mayor parte de su articulado se ha visto superado por los documentos y normas que se aprobaron posteriormente.

La estructura del Reglamento es:

- Título I: Marco de referencia de los Centros de Servicios Sociales.
- Título II: Contenido de los Centros de Servicios Sociales. Prestaciones sociales, condiciones de acceso, derechos y deberes.
- Título III: Del funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales.

Recogía, además, dos anexos relacionados con las "funciones de los profesionales adscritos a los Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid" y los "contenidos técnicos y metodológicos de los Centros de Servicios Sociales".

2.1.- MARCO DE REFERENCIA DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

El **objeto del Reglamento** es regular las competencias, la organización y el funcionamiento de todos los Centros de Servicios Sociales, como **equipamiento básico de la Red de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid**. También viene a desarrollar aquellas prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales Municipales que se gestionarán desde los Centros de Servicios Sociales.

Se establece que cada Centro dividirá el territorio en **zonas**. El acceso a los Centros de Servicios Sociales es directo y desde éstos se derivan a los Servicios Sociales Especializados.

Los **Centros de Servicios Sociales** se encargarán de la atención directa, el estudio y valoración de los estados de necesidad, la gestión de prestaciones y la puesta en marcha de actividades.

2.2.- CONTENIDO DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

En este Título se establecían las **prestaciones básicas del Sistema de Servicios Sociales:**

- **Información y orientación.**
- **Apoyo a la unidad convivencial y ayuda a domicilio.**
- **Prevención e inserción social.**
- **Alojamiento alternativo.**

Para el acceso a estas prestaciones será necesaria la valoración de las situaciones de necesidad por parte de los trabajadores sociales.

Se establecen como derechos y deberes de los usuarios:

Derechos de los usuarios.	Deberes de los usuarios.
. Recibir información de su trabajador social sobre la intervención social desarrollada. . Presentar reclamaciones ante el director, si está disconforme con la actuación del trabajador social.	. Colaborar con el Centro de Servicios Sociales en la resolución del problema planteado. . Informar verazmente a los profesionales implicados en la intervención. . Realizar las actuaciones que se establezcan para la concesión de las prestaciones.

2.3.- FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

Los Centros de Servicios Sociales, para desarrollar el contenido de los programas y la gestión de las prestaciones, se organizan en Unidades de Trabajo, dependiendo éstos de la Dirección del Centro de Servicios Sociales. Estas Unidades son:

- Unidad de Trabajo Social.
- Unidad de Programas.
- Unidad Administrativa.

Unidad Administrativa.	Se encarga de **recibir a los usuarios y canalizar la demanda** planteada por éstos. Va a diferenciar los usuarios susceptibles de atención en el Centro de Servicios Sociales de los que no lo son. Los que sean susceptibles de atención social serán informados por la Unidad Administrativa de los horarios y requisitos de atención.
Unidad de Trabajo Social.	Se le encomienda la **atención directa al usuario** y el contacto con la población y las entidades que forman parte del territorio que abarca el Centro de Servicios Sociales. De esta función se derivan otras como la información, orientación y asesoramiento sobre derechos y recursos sociales, conocimiento de las necesidades sociales del territorio y contar con información sistematizada para la planificación. La Unidad de Trabajo Social sigue el criterio territorial para organizar su trabajo, las cuales se delimitan teniendo en cuenta el número de habitantes, las necesidades de la población, los recursos y equipamientos disponibles. Cada zona tendrá asignado un trabajador social de referencia.
Unidad de Programas.	Los responsables de programas tienen como función dar **apoyo técnico a la Unidad de Trabajo Social** y gestionar las prestaciones contenidas en cada Programa. El Reglamento recoge dos Programas: - **Programa de Prevención y Reinserción.** - **Programa de Convivencia Familiar.**

3.- CIRCUITO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

Las nuevas necesidades sociales, así como el crecimiento de los recursos, han hecho que se introduzcan nuevos cambios en la organización de los Centros de Servicios Sociales. El Ayuntamiento de Madrid emprendió a finales de 1.996 un **proceso de mejora** de los Servicios Sociales, para incrementar la calidad en la atención a los usuarios. Se constituyeron cinco grupos de trabajo, que hicieron un análisis de la situación de los Servicios Sociales y plantearon una serie de propuestas de mejora.

Así, en noviembre de 1.997, se presenta el **Modelo de Atención para los Servicios Sociales Generales.** Su puesta en marcha en los 21 Distritos se llevó a cabo durante el año **1.998.**

El punto de partida para la elaboración del modelo de atención al ciudadano fue el **diagnóstico** sobre la situación de la atención social ofrecida desde los Centros de Servicios Sociales. Para llegar a ese diagnóstico se analizaron datos de atención a los Centros, se facilitaron cuestionarios a los técnicos de los Servicios Sociales, se organizaron grupos de discusión de Trabajadores Sociales de zona y de Programas. Esta información fue analizada por un evaluador externo, señalándose los siguientes problemas como los más significativos:

- Disparidad de modelos organizativos en los Centros.
- Indefinición de objetivos y criterios para la atención.
- Existencia de listas de espera.

Los **objetivos concretos** que se proponía el modelo eran:

- Homogeneizar los modelos de atención en los 21 distritos.
- Racionalizar los recursos, tanto humanos como las prestaciones.
- Agilizar la atención, garantizando la inmediatez en la respuesta.

3.1.- EL MODELO DE ATENCIÓN PARA LOS SERVICIOS SOCIALES GENERALES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA.

El acceso al Centro se realiza a través de la **Unidad Administrativa**, que tiene las siguientes competencias:

- La recepción y canalización de los usuarios.
- Como paso previo debe diferenciar los usuarios susceptibles de atención en un Centro de Servicios Sociales de los que no lo son.
- Los usuarios susceptibles de atención en un Centro de Servicios Sociales son informados por la Unidad Administrativa de los horarios y requisitos para ser atendidos por la UTS de Primera Atención o para darles cita con la UTS de Zona.

UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL (UTS).

Su función general es la atención directa de la ciudadanía que acude a los Servicios Sociales. Esta Unidad se desdobla con la puesta en marcha de manera escalonada del modelo de atención para los Servicios Sociales, estableciéndose dos unidades dentro de la misma:

Unidad de TS de Primera Atención (PA).	Desarrolla una intervención breve en el tiempo y focalizada en aquellos casos que no precisen un seguimiento continuado. Las funciones del trabajador social de primera atención son: acogida/contextualización, información y asesoramiento, orientación, gestión y valoración de determinadas prestaciones, análisis de la demanda distrital, atención grupal, coordinación y cierre/derivación. Las prestaciones que se gestionan en primera atención son aquellas que no requieren seguimiento.

Unidad de TS se Zona.	Son los profesionales encargados de realizar una intervención prolongada, que conlleva seguimiento, en base a un Diseño de Intervención Social, con los usuarios que corresponden a su zona de actuación. Las funciones del trabajador social de Zona son: atención con seguimiento (Historia Social y Diseño de Intervención Social), atención grupal, trabajo comunitario, gestión de prestaciones (que requieren seguimiento).

UNIDAD DE PROGRAMAS.

En los Centros de Servicios Sociales existen dos Programas: el **Programa de Prevención y Familia** y el **Programa de Mayores y Ayuda a Domicilio.** Las funciones principales de los trabajadores sociales responsables de los Programas son:

- Coordinación interna, que se realiza con el equipo del Centro de Servicios Sociales y el resto de los recursos municipales.
- Coordinación externa, que se lleva a cabo con las entidades contratadas y concertadas con el Área de Gobierno, que desarrollan actuaciones en el Distrito, así como con otras entidades que actúen en el mismo.
- Apoyo a las UTS y diseño y desarrollo de proyectos sociales específicos, teniendo en cuenta las necesidades detectadas por la UTS de Zona.

3.2.- EL CIRCUITO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

El circuito de atención es el itinerario por el cual será atendido un ciudadano que acude al Centro de Servicios Sociales. Este circuito se configura en las siguientes fases:

1. **Acceso al circuito.**
2. **Primera Atención.**
3. **Atención en Zona.**

3.2.1.- ACCESO AL CIRCUITO: UNIDAD ADMINISTRATIVA.

El acceso se realiza a través de la Unidad Administrativa, cuya función es la recepción y canalización de los usuarios.

Como paso previo debe diferenciar los usuarios susceptibles de atención en un Centro de Servicios Sociales de los que no lo son. Los usuarios susceptibles de atención son informados por la Unidad Administrativa de los horarios/requisitos para ser atendidos por las UTS de Primera Atención o para darles cita en UTS de Zona (en caso de tener expediente activo en Servicios Sociales).

La Unidad Administrativa debe discriminar las siguientes situaciones de los usuarios:

Usuarios que deben pasar a Primera Atención.	**Usuarios para darles citas en Zona.**
1.- Usuarios nuevos. Se incluyen dos posibilidades: . Aquellos que acceden por primera vez al Centro, y que, por tanto, no tienen expediente en Atención Social Primaria. . Aquellos que tienen expediente, pero que no está en activo porque no se ha dado ninguna atención en los últimos 12 meses. En la práctica se consideran como usuarios nuevos. **2.- Usuarios en situación de urgencia.** Son usuarios que requieren una atención inmediata. Las urgencias tienen carácter prioritario. Se consideran supuestos de urgencia: . Agresiones o malos tratos manifiestos o no, a cualquier persona. . Abandono de personas sin apoyo ni recursos. . Problemas de alojamiento y vivienda sobrevenidos. . Situaciones de desprotección social relacionadas con problemas de salud. . Situaciones de desprotección socio-familiar derivadas de emergencias.	La Unidad Administrativa citará para ser atendidos en la UTS de Zona a: **1.- Usuarios con expediente activo en Atención Social Primaria.** **2.- Usuarios derivados de Primera Atención.**

3.2.2.- UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN.

La UTS de Primera Atención atiende a los **usuarios nuevos** y a los **casos urgentes**. Los casos urgentes pueden acudir:

- Por propia iniciativa.
- Derivados del Servicio de Emergencia Social (Samur Social, Samur Protección Civil …) u otros Servicios.

El **cierre de la intervención en Primera Atención** se puede dar por las siguientes situaciones:

- Por finalización / resolución del caso en Primera Atención.
- Por derivación interna a la UTS de Zona.
- Por derivación externa a otros Servicios / Sistemas de Protección, tanto municipales como no municipales.
- Por abandono.
- Por fallecimiento.

3.2.3.- UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA.

La UTS de Zona atiende a:

- Usuarios derivados por la UTS de Primera Atención.
- Usuarios con expediente activo.

En ambos casos se atiende previa cita dada por la Unidad Administrativa.

La atención en la UTS de Zona sigue los siguientes itinerarios:

- Casos en **intervención exclusiva y específica de Zona**, con comienzo y finalización de la intervención social en Zona.
- Casos **en intervención de zona, con derivación parcial** a otros sistemas de protección social u otras Administraciones. Esta intervención, al igual que la anterior, comienza y finaliza en la Zona.
- Casos **en intervención de zona, con derivación definitiva** a otros servicios / sistemas de protección. En este caso la intervención se inicia desde Zona y se cierran en el momento de proceder a la intervención.

3.3.- FUNCIONES GENERALES DE LOS PROFESIONALES DE LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL.

Del profesional de **Primera Atención:**

- Acogida / contextualización.
- Información / orientación.
- Asesoramiento.
- Cumplimentación de la Ficha de Usuario de Primera Atención (FUPA).
- Gestión.
- Valoración.
- Cierre / derivación.

Del profesional de **Zona:**

- Apertura de la Historia Social.
- Intervención Social con Diseño de Intervención Social (DIS).
- Seguimiento y evaluación de la intervención.
- Cierre / derivación.

4.- CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN SOCIAL.

4.1.- CRITERIOS ORGANIZATIVOS DE LA ATENCIÓN EN HORARIO DE MAÑANA.

Los elementos organizativos más destacados son:

Distribución global del tiempo.

El trabajador social dedica una parte del tiempo a la atención directa: entrevistas, visitas a domicilio, grupos informativos (Primera Atención), intervención comunitaria … Otra parte de su trabajo la dedica a la coordinación, gestión, supervisión, elaboración de informes, elaboración de diseños de intervención social …

Tanto en Primera Atención como en la Zona hay unas ratios generales similares:

- Atención directa a usuarios: 60%.
- Gestión / Informes (y en Zona elaboración y evaluación del DIS): 20%.
- Coordinación / Supervisión / Formación: 20%.

Días y horarios de atención.

En **Primera Atención** se atiende a los usuarios de lunes a viernes, de **9.10 a 13.10** horas (excepto urgencias). Un día a la semana dispone de espacios para realizar gestiones.

En la UTS de Zona se atiende tres días por semana (lunes, miércoles y viernes), de 9.10 a 13.30 horas.

En **Primera Atención** se realizan de 1 a 3 entrevistas con cada usuario, con una duración media de 20 minutos.

- La primera entrevista es siempre sin cita. Si la segunda o tercera son necesarias, se harán con cita por el propio trabajador social de P.A. que ha realizado la primera entrevista.
- En ningún caso la atención en P.A. debe prolongarse durante más de tres entrevistas.

La dedicación del Trabajador Social de Primera Atención es exclusiva y no asumirán otro tipo de tareas. Como criterio general se ha asignado un Trabajador Social de Primera Atención por cada 3 ó 4 Trabajadores Sociales de Zona. Debe preverse su sustitución en caso de necesidad para garantizar la prestación del servicio.

En **Zona** las entrevistas tienen una duración de 40 minutos.

Se prevé la rotación de los profesionales de primera atención y de zona para enriquecer su experiencia laboral y evitar su queme profesional.

Los criterios metodológicos más destacados son:

- En la UTS de Primera Atención se realiza una intervención breve en el tiempo, focalizada, con una primera valoración y resolución ágil. El registro se realiza en base a la **Ficha de Usuario de Primera Atención** informatizada.
- En la UTS de Zona se realiza una intervención programada, temporalizada y con seguimiento. En todos los casos se abre **Historia Social** y se realiza **Diseño de Intervención Social.**

- La atención en la UTS constituye el núcleo central y específico de la intervención social en los Centros de Servicios Sociales. Los Programas son un "apoyo técnico especializado" a la Zona.

Criterios de zonificación de las UTS de Zona.

Los criterios de zonificación se plantean en función del volumen de población, así como de los índices de necesidad y demanda. Se tienen también en cuenta los criterios de contigüidad geográfica (teniendo como referente el Decreto de Zonificación de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid).

Criterios de coordinación de las UTS.

La **dirección del Centro** debe coordinar con todas las unidades que intervienen en el circuito de atención:

- La **Unidad de Primera Atención** se coordinará semanalmente con la Dirección y mensualmente con el resto del equipo.
- La **Unidad de Zona** se coordinará quincenalmente con el director y con los responsables de los dos programas y mensualmente con el resto del equipo.

La reunión de equipo supone un espacio general de coordinación de todas las Unidades de Trabajo Social de los Centros: Primera Atención, Zonas y Programas. Estas reuniones, para ser operativas, deben previamente detallarse en cuanto a orden del día, duración, periodicidad …

5.- METODOLOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL.

5.1.- CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN PARA LA PRIMERA ATENCIÓN.

La importancia de la Primera Atención viene dada por ser la puerta de entrada al Sistema de Servicios Sociales y por su decisivo papel en la valoración inicial de los casos y la detección del riesgo social.

En la Primera Atención se realiza una intervención con las siguientes **características metodológicas:**

- Breve en el tiempo, sin seguimiento.
- Ofrece información y orientación.
- Realiza una valoración rápida.
- Realiza intervención, si procede, en situaciones de crisis.
- Resuelve.
- Finaliza y deriva.

Tal y como recogimos anteriormente –en PA se realizan un máximo de tres entrevistas con una duración máxima de 20 minutos-, con lo que es fundamental focalizar adecuadamente la entrevista para captar adecuadamente la demanda y ajustar la respuesta.

- Los casos que solo precisen información, orientación y gestión puntual de prestaciones, serán atendidos exclusivamente por Primera Atención. Estos casos deberán ser atendidos en un máximo de 3 entrevistas-

- Se gestionarán aquellas prestaciones que no requieren seguimiento y siempre en aquellos casos en que no se van a derivar a Zona. En el caso de que entre las prestaciones valoradas en PA haya prestaciones que requieren seguimiento y otras de PA, ambas prestaciones serán tramitadas desde la Zona.

Estas prestaciones son:

- De la Comunidad de Madrid: residencias de mayores, centros de día, comedores, instalación de teléfonos para mayores, Centros de Discapacitados, Ayudas al transporte para taxi para personas con discapacidad, solicitud de la dependencia.
- Del Ayuntamiento de Madrid: teleasistencia, camas articuladas.

La resolución o finalización de la Primera Atención podrá darse desde la primera, segunda o tercera entrevista. Se procurará que, en cuanto se prevea la necesidad de seguimiento en Zona, se derive sin esperar a realizar las siguientes entrevistas. Esta derivación supone una valoración en la que se recogen los motivos que justifican la intervención con seguimiento desde la Zona.

5.2.- CRITERIOS GENERALES PARA LA INTERVENCIÓN EN UTS DE ZONA.

La intervención en UTS de Zona es una intervención sistematizada que requiere seguimiento. Esta intervención:

- Parte del conocimiento de la realidad.
- Formula hipótesis de trabajo.
- Plantea objetivos en diversos niveles:

- De **prevención**, si van dirigidos a evitar la aparición de un problema.
- De **modificación**, destinados a provocar o inducir cambios.
- De **contención**, orientados a evitar el deterioro de una situación.

Según el Reglamento de Centros, el proceso de intervención social contiene las siguientes fases: estudio, valoración diagnóstica y diseño de intervención social (DIS). El diseño recoge los momentos centrales de la intervención: formulación, revisiones y finalización con la evaluación correspondiente. Todos los casos atendidos desde la UTS de Zona deben tener elaborado el DIS. El trabajador social de zona será siempre el profesional de referencia en estos casos.

El soporte específico para esta intervención lo constituyen la **Historia Social** y el **Diseño de Intervención Social.** A efectos del DIS, la entrevista se constituye en la unidad de medida para determinar la intensidad y frecuencia de la intervención (la visita domiciliaria tiene la misma consideración que una entrevista).

La **intensidad** en la intervención viene definida por el mayor o menor tiempo de dedicación a un caso –número de entrevistas programadas-. La **frecuencia** hace referencia al número de veces que se mantienen entrevistas en un período de tiempo determinado.

Así, podemos diferenciar entre:

- Intensidad alta, de 7 a 14 entrevistas anuales.
- Intensidad media, de 3 a 6 entrevistas anuales.
- Intensidad baja, de 1 a 2 entrevistas anuales.

La duración del proceso de intervención recogido en el DIS no debe exceder de dos años. Se puede reabrir un nuevo proceso de intervención transcurrido un tiempo tras el cierre de la última intervención, si se diesen circunstancias que así lo aconsejen.

Es responsabilidad del trabajador social de zona mantener la información de los expedientes actualizada, codificada y completa, con el apoyo de la Unidad Administrativa. La Historia Social es un instrumento exclusivo de la UTS de Zona.

Los **niveles de intervención** con los que va a intervenir la zona son el individual/familiar, el grupal y el comunitario. Las actuaciones más frecuentes en cada nivel son:

- A nivel individual/familiar:
- Recepción de los casos derivados de PA.
- Entrevistas en el despacho.
- Visitas domiciliarias.
- Coordinación con otros profesionales y servicios.
- Gestión de recursos.
- A nivel grupal:
- Análisis de la demanda y atención que se repite periódicamente en la zona.
- Propuestas a la dirección sobre intervenciones grupales.
- Prediseño del grupo.
- Elaboración de un diseño definitivo de intervención grupal.
- A nivel comunitario:
- Valoración de los casos que requieren abordaje comunitario.
- Participación en reuniones y asociaciones de la zona.
- Coordinación con las redes naturales y sociales de la zona.

5.3.- LA ATENCIÓN DE LAS URGENCIAS SOCIALES.

Los Centros de Servicios Sociales tienen como uno de sus cometidos, la atención a las **urgencias sociales de carácter individual**. La atención de las urgencias sociales debe garantizarse durante todo el horario de apertura del Centro de Servicios Sociales, ya que el resto del horario esta atención se asume desde el dispositivo específico de atención a las emergencias sociales, el Samur Social.

La atención a las urgencias sociales desde la Atención Social Primaria viene enmarcada por dos criterios:

- La vinculación territorial del afectado.
- El horario de apertura de los Centros de Servicios Sociales.

Por tanto, personas sin vinculación territorial con el municipio de Madrid, o con ella, pero que requieran atención inmediata que no pueda esperar al horario de atención de los Centros, serán atendidas desde el Samur Social.

La atención a los casos urgentes, por tanto, tiene carácter prioritario y se atienden durante todo el horario laboral. Estos casos prevalecen en la atención sobre ser nuevo o no.

Se consideran casos urgentes aquellos que están incluidos en los **supuestos de urgencia:**

1. **Agresiones o malos tratos**, manifiestos o no, a cualquier persona (mujer, menores, ancianos).
2. **Abandonos:** personas sin apoyo ni recursos personales o familiares (ancianos, menores en presunta situación de desamparo).
3. **Problemas de alojamiento / vivienda:** desahucios o demoliciones no previstos o desconocidos previamente desde los Servicios Sociales.
4. **Situaciones de desprotección social relacionadas con problemas de salud:** altas hospitalarias de personas con falta de autonomía personal sin apoyo familiar suficiente y/o escasez de recursos económicos.
5. **Situaciones de desprotección socio-familiar derivadas de situaciones de emergencia:** explosiones, inundaciones, accidentes … tras la atención de los servicios de emergencia.

Las derivaciones del Samur Social tienen la consideración de urgencias si están dentro de alguno de los anteriores supuestos, de lo contrario, siguen el protocolo habitual de atención.

Tras realizarse la acogida de la situación de urgencia desde la Unidad Administrativa, el caso será derivado a los trabajadores sociales de Primera Atención. Si tiene expediente activo en zona, se contactará con el trabajador social de zona para valorar si puede asumir la intervención de urgencia. Si la zona no está disponible, se asume desde Primera Atención.

5.4.- LA ATENCIÓN SOCIAL CESDE LA UNIDAD DE PROGRAMAS.

Según se recoge en el Modelo de Atención, la Unidad de Programas va desarrollar programas generales que se sitúan al mismo nivel que el trabajo social de zona.

El Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales planteaba que la Unidad de Programas tiene como funciones el desarrollo de los Programas de Convivencia Familiar y de Prevención-Reinserción, para proporcionar apoyo técnico especializado a la Unidad de Trabajo Social, así como para gestionar las prestaciones contenidas en cada uno de ellos.

En la actualidad, los Programas que se desarrollan desde los Centros de Servicios Sociales, son dos:

- **Programa de Prevención y Familia.**
- **Programa de Mayores y Servicio de Ayuda a Domicilio.**

Esta reorganización se produjo para poder lograr los siguientes objetivos:

- Racionalización del uso y de la distribución de los tiempos y tareas de los profesionales.
- Deslinde de las tareas de atención directa y las de coordinación / apoyo técnico.
- Coordinación de las prestaciones y proyectos, así como apoyo técnico a la atención realizada por las zonas.

El criterio general es la adscripción de un trabajador social para cada uno de los dos Programas, con lo que habitualmente habrá dos trabajadores sociales de Programa.

Función de coordinación de la Unidad de Programas.

El eje fundamental de la Unidad de Programas lo constituye la **función de coordinación.**

La coordinación es la actividad mediante la que se intercambia información, se discuten estrategias, se toman acuerdos, etc en un marco profesional, con dos o más agentes o profesionales implicados de una misma o distinta institución.

Podemos diferenciar dos tipos de coordinación:

a.- Coordinación interna.

b.- Coordinación externa.

La **coordinación interna,** incluye aquella que el Trabajador Social del Programa realiza con:

- La U.T.S. de Zona.
- El equipo del Centros de Servicios Sociales.
- El Jefe de Sección/Director del Centro
- Los Centros de Servicios o Recursos Sociales Municipales (CAD, ETMF, Centros de Mayores…)

La coordinación interna tiene como eje central de **interrelación del Programa con la U.T.S. Zona.**

La coordinación externa, incluye todos aquellos contactos que el T.S, de Programa establece con:

- Las Entidades Contratadas/Concertadas por el Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía que desarrollan Proyectos o prestaciones en el marco de los Programas de los Servicios Sociales Generales.

- Las Entidades que desarrollan Proyectos específicos del Distrito.

- Otras Entidades, Comisiones, Mesas de Trabajo...

Las funciones y tareas enmarcadas en la **Coordinación Interna** son:

- Estudiar y actualizar problemáticas y demandas a nivel distrital en base a la información facilitada por los T.S. de Zona. Devuelve a las Zonas y a la Dirección del Centro, la información elaborada.
- Estudiar y actualizar criterios, baremos, servicios preestablecidos, perfiles de usuario y prestaciones.
- Controlar altas, bajas, modificaciones, niveles de ocupación y gasto prestaciones y servicios. También gestiona la lista de espera de las prestaciones propias del Programa.
- Establecer reuniones con los TS de Zona.
- Informar y orientar a los T.S. sobre prestaciones, servicios y todo tipo de recursos relacionados con el ámbito de su Programa.
- Traspasar a los T.S. de Zona, las incidencias sobre prestaciones y Servicios.
- Acometer acuerdos y directrices derivados de la coordinación con el Área de Gobierno.

Las funciones y tareas enmarcadas en la **Coordinación Externa** son:

- Establecer los contenidos, fechas y duración de las reuniones que mantienen con las Entidades adjudicatarias atendiéndose a los correspondientes contratos o convenios.
- Recoger y canalizar informaciones e incidencias de otros Servicios. Es el interlocutor y referente para la coordinación con otros recursos e instituciones.
- Participar en las reuniones establecidas por otros Servicios Municipales o no en función de las prioridades establecidas.

- Participar en mesas y comisiones de trabajo de ámbito distrital relacionadas con el Programa en base a las prioridades previamente establecidas en el Centro de Servicios Sociales...

También pueden asumir funciones y tareas en relación al **diseño y desarrollo de proyectos distritales específicos.**

- Diseño de los Proyectos, teniendo en cuenta las demandas y problemáticas detectadas por la U. T .S. de Zona.
- Desarrollo y evaluación de los mismos (puede implicar la mayor parte de las funciones y tareas previstas en coordinación interna/externa).

En el diseño y desarrollo de Proyectos distritales específicos, el T.S. de Programa es el referente pero puede implicar a los T.S. de Zona, tanto en el diseño como en la realización de determinadas actividades de carácter grupal o comunitario previstas en el Proyecto.

En relación a los **expedientes relacionados con menores** las informaciones telefónicas relacionadas con menores y familias desde otros servicios (colegios, centros de salud, agentes tutores …) serán recibidas por el trabajador social responsable del Programa de Prevención y Familia, remitiendo esta información a la zona correspondiente.

5.5.- ATENCIÓN SOCIAL A MENORES.

Existen protocolos de actuación en aquellos casos que afecten a menores y que sean planteados bien desde la Atención Social Primaria o por otras administraciones o entidades.

Las informaciones telefónicas de casos de menores y familias desde otros servicios (colegios, centros de salud …) serán recibidas por la trabajadora social del Programa de Prevención y Familia, que remitirá la información a la UTS de Zona correspondiente. Hay que tender a que este tipo de informaciones se realicen por escrito.

Nos podemos encontrar con varios supuestos:

- Las solicitudes de información desde Comisión de Tutela del Menor serán respondidas por la UTS de Zona.
- Los casos de menores con historia social, por la UTS de Zona.
- Los casos sin historia social serán atendidos por la UTS de Primera Atención, que determinará si procede la derivación a la UTS de Zona.
- Casos con expediente previo de protección en CTM: diligencias informativas, tutela o guarda, competen a la UTS de Zona.
- Solicitudes desde la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción Social: sean conocidos previamente o no, serán atendidos desde la UTS de Zona.
- Los casos sin expediente previo de protección en CTM son atendidos desde la Atención Social Primaria.

6.- PLAN DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

6.1.- INTRODUCCIÓN.

El punto de partida del Plan de Atención Social Primaria es la **orientación hacia el usuario**, proponiéndose introducir los ajustes necesarios para ese fin en la organización de este primer nivel del sistema público de Servicios Sociales en la ciudad de Madrid.

Este sistema de Servicios Sociales es un **sistema mixto**, en el que los poderes públicos se responsabilizan de promover y garantizar los derechos sociales, donde la iniciativa social y la iniciativa empresarial concurren en la prestación directa de determinados servicios.

Los Servicios Sociales, como estructura de gestión:

- Son una **organización compleja**, por la diversidad de clientes y de situaciones con las que intervienen.
- Que deben combinar la **garantía que implican normas y procedimientos con la flexibilidad** que debe estar presente en las relaciones interpersonales.
- Son **organizaciones jóvenes** con un rápido proceso de crecimiento.
- Se añade la complejidad de la **concurrencia de las administraciones central, autonómica y local.**

La presencia de una ciudadanía cada vez más informada y consciente de sus derechos ha sido también un estímulo a la innovación de los Servicios Sociales madrileños.

Puntos críticos.

Los **principales puntos críticos** que hay que abordar, en relación a la organización actual, de los Servicios de Atención Social Primaria, son los siguientes:

1. Falta de delimitación de funciones en el nuevo organigrama.
2. Desequilibrios muy notables en la dotación de recursos humanos.
3. Desequilibrios en la dotación de Centros de Servicios Sociales.
4. Modelo mixto de gestión no integrado.
5. Mejorable utilidad del Sistema de Información.
6. Falta de formación gerencial en los directivos y cuadros medios, tanto de los Servicios Sociales Distritales como del propio Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales.
7. Ausencia de imagen corporativa.
8. Desviaciones en el modelo de atención establecido.
9. Falta de continuidad entre atención individual/programas/grupos/intervención comunitaria.
10. Insuficiente integración de criterios y actuaciones entre las Direcciones Generales del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales.
11. Mejorable orientación al usuario como centro del sistema de atención social primaria.

6.2.- VISIÓN DEL FUTURO DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

Las señas de identidad de los Servicios Sociales de Madrid deben ser las siguientes:

Los Servicios Sociales son conocidos, y reconocidos, por los ciudadanos porque trabajan en el núcleo de los derechos sociales, los responsables municipales lo saben y lo promueven.

Organizan y prestan servicios, enmarcados en un Sistema Público de gestión mixta que se concibe como una red eficaz e interconectada de centros y servicios de distrito, con equipos capaces de garantizar la calidad en la atención y la gestión integrada de todos los programas y prestaciones sociales municipales.

Asumen el reto permanente de cercanía a los ciudadanos y adaptación e innovación en la respuesta a las personas con necesidades sociales de cada distrito.

6.3.- MISIÓN DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

El principal cometido de la Atención Social Primaria –para sus directivos, profesionales de atención directa y responsables del Área de Gobierno-, es:

Prestar servicios de atención social para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Madrid, promoviendo la innovación y ofreciendo respuestas ágiles y eficaces para la resolución de sus demandas y la satisfacción de sus necesidades.

6.4.- OBJETIVOS DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

Objetivo general.

Afianzar la **presencia, reconocimiento e identificación de la Atención Social Primaria entre la ciudadanía madrileña, como canalizadora del sistema de prestaciones de responsabilidad pública** que expresa la solidaridad y el compromiso de la sociedad hacia el conjunto de sus miembros.

Objetivos específicos.

1.- Avanzar hacia la **reorganización de los Servicios Sociales, ofreciendo servicios con la máxima calidad y eficacia a la población.**

2.- **Ampliar, consolidar y adaptar los recursos y equipamientos de cada distrito a sus características**, ajustando su organización a criterios sociodemográficos y territoriales.

3.- Dirigir al conjunto de la organización a establecer **criterios compartidos y compromisos para su concreción en el Área y en los distritos.**

6.5.- ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

6.5.1.- ESTRATEGIA I. MEJORA DE PROCESOS.

Se pretende:

- Impulsar la planificación "en cascada" y coordinada entre el Área y los Departamentos distritales, orientada por objetivos.
- Llevar a cabo un conjunto planificado de investigaciones sociales, combinando estudios generales con aspectos particulares de la realidad madrileña.
- Simplificar los procedimientos, lo que implica eliminar trámites innecesarios para los usuarios.
- La disminución de la carga administrativa de los profesionales que realizan la intervención social, distinguiendo funciones administrativas y técnicas en los procedimientos de tramitación de las prestaciones sociales, así como unificando y simplificando los protocolos de intervención.

Programas.
Programa 1. Impulso a la planificación y funcionamiento por objetivos.
El programa describe las medidas necesarias para hacer factible **un funcionamiento por objetivos en el conjunto de la organización, reforzando a este fin la planificación y la investigación.**
Programa 2. Simplificación y sistematización de procesos y métodos de trabajo.
El Programa consiste en el estudio, análisis y realización de propuestas de agilización y mejora de los procedimientos administrativos vigentes, que se recogerán en un **Manual de Procedimiento que servirá para facilitar la tarea del personal de ASP y reducir la documentación a aportar por los usuarios al mínimo imprescindible.**
Programa 3. Fomento de la innovación.
El programa describe las medidas necesarias para acometer **procesos de innovación tanto en los procesos y métodos de trabajo de los profesionales como en las maneras en que los ciudadanos se relacionan con los Servicios Sociales.**

6.5.2.- ESTRATEGIA II. DESARROLLO DE RECURSOS.

Esta estrategia pretende dar respuesta a algunos de los puntos críticos que se han evidenciado en el análisis de la situación.

Este proceso va a implicar un equilibrio entre la homogeneidad de servicios iguales para todos los ciudadanos y diferenciación de territorios susceptibles de recibir mayor demanda de servicios, por la composición de su población.

La mejora de la capacidad profesional de los recursos humanos es básica, orientada al perfeccionamiento del personal para optimizar su adecuación a sus funciones y prepararlo para los cambios –organizacionales y sociales- previstos.

Programas.
Programa 1. Ordenación y formación de los recursos humanos.
El programa describe los **crecimientos de plantilla necesarios** para ofrecer una atención homogénea y suficiente a toda la población de la ciudad de Madrid, así como las propuestas iniciales para **un plan de formación permanente.**
Programa 2. Gestión integral de la red de Servicios Sociales Municipales.
El programa describe las **actuaciones a seguir en los Servicios Sociales de gestión** indirecta financiados por el Ayuntamiento de Madrid, para que se encuentren rentabilizados y gestionados de manera integral, garantizándose el **principio de responsabilidad pública en la promoción, planificación, coordinación, control, ejecución y evaluación** de los mismos, Estas mejoras se sustentan en un enfoque de "arriba abajo", que abarca desde la planificación y programación hasta el proceso de intervención social.
Programa 3. Mejora de la oferta y proximidad de la atención.
El programa describe **los aumentos necesarios en los dispositivos de atención social a los ciudadanos,** que se traducen en la **creación de nuevos Centros de Servicios Sociales y Puntos de Atención Social, en la adecuación de la oferta horaria a las expectativas de los potenciales usuarios, y en la mejora de la capacidad de respuesta en los casos de urgencia.** Se contemplan ajustes del vigente modelo de organización, orientados a facilitar el contacto con los profesionales de los Centros.

6.5.3.- ESTRATEGIA III. DESARROLLO CORPORATIVO.

Es una estrategia orientada a la **calidad**, incluyendo los mecanismos e instrumentos habituales para la gestión de la calidad en las organizaciones modernas –públicas o privadas-, junto a medidas propias de los SS.SS. Se fundamenta en la comunicación -interna y externa-, en la configuración y transmisión de una imagen propia y global de los Servicios Sociales (imagen corporativa) y en el desarrollo de instrumentos específicos de comunicación y relación con los clientes-usuarios.

En el ámbito de la calidad será fundamental la implantación de la **figura del profesional de referencia** –según la Ley, aquel que conduce el proceso de la intervención social-. Para facilitar su identificación se diseñará y aplicará en todos los Centros una **tarjeta de usuario**, con las indicaciones básicas para facilitar el contacto con los profesionales adscritos al territorio.

Programas.
Programa 1. Coordinación y comunicación.
El programa pretende arbitrar medidas tendentes a **optimizar los procesos de coordinación y comunicación** entre los diferentes segmentos del sistema municipal de Servicios Sociales, de manera que se favorezca **una visión global de los Servicios Sociales.** Se propone elaborar un **Plan de Comunicación Interna,** prestando una particular atención a aquellos profesionales que se incorporan como nuevos miembros a los Servicios Sociales. Es fundamental la puesta en funcionamiento de **proyectos transversales que persiguen objetivos propios de diferentes Direcciones Generales del Área de Gobierno,** para destinatarios que constituyen grupos de únicos de población.

Programa 2. Identidad y visibilidad de la Atención Social Primaria.
En el programa se agrupan tres tipos de acciones que responden, respectivamente, a las carencias detectadas en la **presentación de una clara imagen de los Servicios Sociales,** a la necesidad de **comunicar sus actuaciones a los usuarios e instituciones u organizaciones con las que se relaciona,** y al cumplimiento de la norma legal en uno de los aspectos con mayor repercusión en la percepción de los Servicios Sociales como **derechos prestados con calidad.**
Programa 3. Promoción de una cultura del servicio orientada al cliente y a la calidad.
El programa describe las actuaciones encaminadas a lograr una mejor **incorporación de los valores y preferencias de los ciudadanos en el funcionamiento de la atención social,** facilitando la configuración de una demanda informada en relación con la gama de servicios y prestaciones ofertados. Se establecen compromisos sobre determinados aspectos de funcionamiento, extendiendo los ámbitos del servicio guiados por **criterios de calidad,** e incorporando como factor orientador significativo **el nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio recibido.**

6.5.4.- ESTRATEGIA IV. ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.

La aplicación de la Ley 39/2.006 tiene una evidente repercusión en los Servicios Sociales Municipales, en concreto en la ASP, debido a su proximidad a los ciudadanos, con un papel fundamental en la **detección, diagnóstico, orientación e información** sobre los beneficios de la misma, así como sobre la aplicación de las prestaciones. La atención a la dependencia incorporará a una parte de la población que tenía escaso contacto con los SS.SS.

La intervención se tendrá que orientar hacia el **trabajo en equipo y en red**, especialmente articulando la atención social primaria y la atención social especializada.

Esta estrategia busca disponer de una **estructura interna que facilite la puesta en marcha y aplicación de la Ley 39/2.006**, garantizando la mejor atención a los solicitantes y posibles beneficiarios de las prestaciones y servicios previstos en la misma, asegurando la mejor coordinación de la red de Servicios Sociales.

Programas.
Programa 1. Información, orientación y atención a usuarios.
Este programa comprende los objetivos, metas y actuaciones de los Centros de Servicios Municipales en relación a la **información, orientación y atención a los ciudadanos interesados en el nuevo sistema de atención a la dependencia.** Se prevén los **instrumentos para proporcionar una información de carácter general a todos los públicos.** Como medio para apoyar la mayor calidad de la información y orientación ofrecida, se propone la realización de **módulos formativos específicos en materia de dependencia.**
Programa 2. Gestión municipal del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
El programa contempla **la creación de una estructura funcional** (en la Dirección General correspondiente) **destinada tanto a ordenar la gestión de las solicitudes, como a realizar el seguimiento de la resolución de las mismas y a programar el sucesivo desarrollo y aplicación de la Ley en el ámbito municipal.** Estas actuaciones están diseñadas con una **orientación al usuario**, concediendo especial importancia a las fases de gestión y seguimiento.

Programa 3. Coordinación, seguimiento y evaluación.
El programa describe **los procedimientos de evaluación y seguimiento, así como los mecanismos de coordinación y cooperación que resultan necesarios para asegurar la eficacia y mejora continua en la atención a las situaciones de dependencia.**

7.- PLAN DE MEJORA DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

El **22 de noviembre de 2.017** se celebró una Jornada promovida por el Ayuntamiento de Madrid para compartir entre los profesionales de Atención Social Primaria el trabajo realizado de análisis y las propuestas de mejora del actual modelo de atención.

En este apartado presentamos las conclusiones de dicho encuentro.

7.1.- DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DEL MODELO ORGANIZATIVO DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Todo modelo organizativo ha de ser congruente con las **características del entorno social** en el que debe operar. En este sentido el diseño del "modelo de atención" implantado en 1998-1999 pretendía responder a las disfunciones detectadas y ofrecer una mejora de la calidad de la atención, teniendo en cuenta los recursos disponibles y las necesidades sociales existentes en aquellos momentos.

Pasados más de 15 años desde esta puesta en marcha, resulta razonable revisar la congruencia de aquel modelo en relación con el entorno social y organizativo actual.

Para ello hemos recurrido a una serie de variables que tienen que ver con la demanda, la gestión de servicios y prestaciones y en su caso con la dotación de recursos humanos.

Más allá de estos indicadores cuantitativos habría que mencionar el impacto cualitativo que sobre el funcionamiento de la atención social municipal han supuesto algunos eventos político-administrativos como son la implantación de la "**Ley de la Dependencia**" (2007), la adopción de la **Ordenanza de Prestaciones para Mayores** (2009) y la de **Ayudas Económicas** (2004), o la propia **ampliación del número de Centros de Servicios Sociales**.

Por lo demás, con independencia de todos estos componentes, otro dato a tener muy en cuenta en este análisis del entorno es que a partir de 2008-2009 España se ha visto afectada por una severa **recesión económica** que inevitablemente ha venido afectar al bienestar de la población madrileña y su demanda de protección social proporcionada por los servicios sociales municipales.

A lo largo de este periodo se han producido diversos cambios en los sistemas de información y los criterios de contabilización de tal manera que algunos de los datos de usuarios o expedientes utilizados en el análisis hay que tomarlos más como un indicio que como una magnitud exacta. Por otra parte, debido a estos condicionantes, en ciertos casos no se dispone del dato para algún año concreto.

- Con independencia de esos márgenes de error previsibles, podemos decir que **el número de usuarios se ha triplicado en lo que respecta a la Primera Atención**.
- En cuanto a la UTS de Zona el crecimiento ha sido todavía más espectacular, de tal manera que **se ha multiplicado por cuatro en el periodo 1999-2015 el número de Historias Sociales abiertas**.

- En lo que respecta a las **"cargas de trabajo" derivadas de la tramitación de prestaciones más masivas** tendríamos los siguientes datos para el citado periodo 1999 (año de la implantación del nuevo modelo en los 21 distritos) hasta el año 2015.

- El número de usuarios anuales del SAD para Mayores se ha quintuplicado (incluyendo en este caso los beneficiarios por Dependencia)
- El número de beneficiarios de RMI se ha multiplicado por 2,5 en el periodo considerado
- El número de perceptores de Ayudas Económicas municipales se ha duplicado
- La puesta de marcha de la Ley de la Dependencia ha supuesto la información y orientación de más de 20.000 solicitantes al año, con sus correspondientes trámites de consulta e informe de entorno preceptivos.

Frente a este contexto cabe constatar que el incremento en la plantilla de profesionales ha supuesto como máximo el duplicar los recursos humanos existentes al comienzo de la implantación del modelo de atención en 1999 (aunque en este caso habría que tener en cuenta que una parte de esos puestos de nueva creación han sido de "jefaturas" y no de atención directa. También habría que señalar que en muchos momentos esas plazas teóricas han estado vacantes como consecuencia cambios de puesto o distrito, bajas prolongadas, excedencias, etc.).

En relación al **circuito de atención** se han detectado las siguientes situaciones:

En Primera Atención.	. Estancamiento de la PA → menor capacidad de recepción / entrada de usuarios. . Disminución de la ratio de entrevistas por profesional. . Incremento del número de entrevistas por usuario. En la práctica ha dejado de ser un servicio ágil y sustentado en una intervención breve. Igualmente ha aumentado el plazo para acceder a la primera cita en los servicios sociales.
En Zona.	. Progresivo incremento del número de usuarios. . Incremento del número de entrevistas por profesional (se ha pasado de 6,1 entrevistas diarias -2.012- a 9,3 -2.015-). . Incremento de la intensidad (se ha pasado de 1,1 citas x usuario a 1,7). . Soluciones adaptativas → entrevistas telefónicas.
Turno de tarde.	. Canaliza casi 1/3 del total de usuarios de PA. . Se consolida la tendencia de incremento de volumen de atención, tanto en PA como en zona.
Acceso a la atención: primera cita.	Es un elemento fundamental en la valoración de la ciudadanía. Los problemas se concentran en algunos distritos, con frecuencia asociados a factores circunstanciales: bajas o vacantes de personal, tareas nuevas no programadas …
Peso de las tareas de gestión.	La práctica profesional puede definirse en los servicios sociales municipales como un 50% de intervención social y un 50% de gestión.
Trabajo administrativo.	Es necesaria una dotación adecuada de personal administrativo y otras figuras de apoyo (Auxiliares de Servicios Sociales o personal técnico Auxiliar de Integración) para asumir parte de esas tareas de gestión y tramitación.

En relación a la **valoración de la Primera Atención:**

Puntos fuertes.	Puntos débiles.
. Agiliza el acceso a los casos nuevos. . Garantiza la especialización de la atención. . Discrimina de forma ágil el tipo de intervención.	. Genera confusión en los ciudadanos. . Problemas de coordinación entre los profesionales. . Retrasa el abordaje efectivo de los problemas.

7.2.- PROPUESTAS DE MEJORA.

Este **Plan de Mejora** queda alineado con la estrategia del Ayuntamiento de Madrid, en sus ejes **"Una ciudad cercana, cohesionada y habitable"** y **"Una ciudad centrada en las personas, solidaria e inclusiva"**, dentro de los objetivos estratégicos de **"Promover la cohesión y el equilibrio territorial"** y **Garantizar la equidad social reconociendo la diversidad de la población de Madrid".**

OBJETIVO GENERAL.
Mejorar el acceso de la ciudadanía a la red de Atención Social Primaria del Ayuntamiento de Madrid, como canalizadora del sistema de servicios y prestaciones sociales de responsabilidad pública municipal, y motor de solidaridad e inclusión social.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.	
OE 1	Servicio accesible.
OE 2	Gestionar con criterios de eficiencia.
OE 3	Reequilibrio territorial.
OE 4	Las personas: el principal recurso de atención social.
OE 5	Las TIC's como instrumento para el cambio.

OBJETIVOS OPERATIVOS.	
OO 1	Dimensionar la dotación de personal y equilibrar cargas de trabajo.
OO 2	Revisar el turno de tarde para asegurar su viabilidad y equiparación.
OO 3	Mejorar el modelo de relación y los canales de comunicación con el ciudadano.
OO 4	Recuperar tiempo para la intervención social.
OO 5	Optimizar las agendas de los profesionales de cara a un uso del tiempo más eficaz.

OO 6	Promover la intervención grupal.
OO 7	Ampliar y mejorar la oferta formativa a los profesionales de los servicios sociales.
OO 8	Garantizar la homogeneidad organizativa mediante la revisión de las divergencias en los criterios de funcionamiento.
OO 9	Revisión y actualización de los aplicativos de gestión de los servicios sociales.

7.3.- ÁREAS DE MEJORA.

7.3.1.- LOS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES.

La plantilla de profesionales de los Departamentos de Servicios Sociales está compuesta por personal técnico (profesionales de Trabajo Social y personal Técnico de Acogida e Integración Social) y profesionales de apoyo (personal Administrativo, Auxiliar de Servicios Sociales, Auxiliar Administrativo, Secretarías y Personal de Oficios Internos).

El número de profesionales

El Plan de Gobierno 2015/2019 establece como objetivo que se realizará un *"Incremento y/o redistribución de los efectivos de los Centros de Servicios Sociales, personal técnico, personal auxiliar y de apoyo administrativo a la atención social, para alcanzar una ratio de atención de 1 trabajador/a por cada 4.500 habitantes"*. Teniendo en cuenta la población actual de la ciudad de Madrid, para alcanzar ese objetivo, la plantilla total de DTS (Diplomados en Trabajo Social) en los centros debería alcanzar los 707 profesionales.

Nuevos perfiles profesionales

Una de las cuestiones a abordar es la composición de los equipos de trabajo, no solo en cuanto al número de efectivos, sino en el tipo de profesionales que deben de componer los equipos de trabajo de los Centros de Servicios Sociales.

Los grupos de trabajo han identificado tres Unidades Funcionales en los Centros de Servicios Sociales, aparte de la Dirección de centro, con especificación de los perfiles profesionales necesarios para el correcto desempeño de las tareas a desarrollar, de acuerdo a lo siguiente:

UNIDAD FUNCIONAL.	PERFIL PROFESIONAL.
Acogida e Información.	- Técnico/a de Acogida e Integración Social. - Auxiliar de Servicios Sociales. - Trabajador/a Social.
Tramitación / Gestión.	- Administrativo/a. - Auxiliar administrativo/a. - Técnico/a de Gestión.
Intervención Social.	- Trabajador/a Social. - Psicólogo/a. - Educador/a Social. - Terapeuta Ocupacional.
Dirección.	- Trabajador/a Social. - Auxiliar de Secretaría.

Definición de plantillas tipo por CSS

La composición de los equipos de trabajo de los Centros de Servicios Sociales vendrá definida en función de una serie de variables relacionadas con las características sociodemográficas de la zona de referencia, junto con las de atención social. No obstante, para garantizar el correcto funcionamiento de los Centros y prestar una atención de calidad al ciudadano, así como el desempeño profesional en condiciones de seguridad y de igualdad respecto a otros trabajadores municipales, se deberá garantizar una plantilla básica, que los grupos focales identifican de acuerdo a lo siguiente:

UNIDAD FUNCIONAL	PERFIL PROFESIONAL		
	Turno de mañana.	**Turno de tarde.**	**Sin especificar.**
Acogida e Información	. 2 Aux. SS.SS. . 1 DTS.	. 1 Aux. SS.SS. . 1 DTS.	. 1 TAIS. . 1 psicólogo/a.
Tramitación/Gestión	. 1 Admtvo. . 2 Aux. Admon. . 1 TG.	. 1 Aux Admon.	. 1 Educador/a. . 1 Terapeuta Ocup.
Intervención Social.	. 3 DTS.	. 3 DTS.	

7.3.2.- EL TURNO DE TARDE.

El Plan de Atención Social Primaria 2008-2011, contemplaba la apertura paulatina en horario de tarde de los centros de servicios sociales en los 21 distritos. Entre otros, los objetivos que se pretendían eran:

- Mejorar la accesibilidad a la atención social, mediante la ampliación del horario de atención a la ciudadanía, dando la opción de ser atendido en horario de tarde.
- Favorecer la adecuación de los horarios y servicios municipales a las nuevas realidades y demandas de los ciudadanos.

La atención a la ciudadanía, en el turno de tarde, está en funcionamiento desde los años 2008/09 en los 21 distritos del municipio y su organización está regulada por la Instrucción 1/2014 de la Dirección General de Mayores y Atención Social.

Los problemas identificados en el Turno de Tarde tienen que ver con la insuficiente dotación de medios personales, circunstancia que no garantiza la atención al ciudadano y que en ocasiones ha derivado en el cierre de los Centros. Las personas profesionales se sienten solas y con una carga de trabajo superior a trabajadores/as del turno de mañana: sus agendas son diferentes, el modelo organizativo también lo es, sus condiciones laborales no son las mismas... Se manifiesta por tanto la necesidad de **equiparar el funcionamiento de los CSS, sea cual sea su horario de atención, y ante todo garantizar una atención de calidad a los ciudadanos.**

7.3.3.- LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO.

Las entidades locales se caracterizan por ser la administración más cercana a la ciudadanía, por lo que la accesibilidad de los servicios públicos es uno de los principales valores de la organización a preservar y mejorar.

Este principio básico toma aún mayor relevancia cuando las personas a las que nos dirigimos son aquellas que se encuentran en situación de dificultad social; facilitar el acceso mediante la apertura de nuevos canales comunicación, utilizar las nuevas tecnologías como elemento para una gestión más eficiente, diversificar los servicios de información y gestión de prestaciones sociales..., son medidas que mejorarán la relación de los Servicios Sociales con la ciudadanía.

Analizado el actual modelo de relación con la ciudadanía, básicamente presencial, se detecta lo siguiente:

- **Deficiente cartera de trámites electrónicos**. El catálogo de recursos y prestaciones gestionadas desde los Servicios Sociales supera la centena de procesos diferentes, sin embargo, sólo uno de ellos se puede tramitar de forma telemática.
- **Infrautilización del canal telefónico:** es necesario dar mayor protagonismo a la atención telefónica especializada, tanto por parte de agentes de Línea Madrid mediante la mejora de los contenidos Web, como por profesionales de los servicios sociales mediante la apertura de un canal de atención telefónica estandarizado.
- **Necesidad de incorporar el correo electrónico como canal de comunicación** dentro del proceso de intervención social individual/familiar.

7.3.4.- LOS PROCESOS DE TRABAJO.

Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, el catálogo de recursos y prestaciones gestionados por los Servicios Sociales supera la centena de procesos diferentes, cada uno de ellos con su correspondiente procedimiento y documentación técnica. Por otro lado, hay que considerar la propia organización municipal, según la cual, los Servicios Sociales dependen orgánicamente del Distrito y funcionalmente del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, lo que añade complejidad en la gestión de los procesos de trabajo. Además, no podemos olvidar que los Servicios Sociales Municipales son los encargados de la tramitación de las prestaciones sociales del ámbito autonómico y que por tanto, es la Comunidad de Madrid, quien marca las reglas de gestión de sus servicios. Todas estas circunstancias derivan en un complejísimo mapa de gestión de procesos que requiere de claridad y mayor simplicidad.

7.3.5.- LAS AGENDAS DE LOS PROFESIONALES.

Las agendas de profesionales de los Servicios Sociales son el instrumento clave para organizar y garantizar la homogeneidad de la atención social tanto a nivel territorial como en las diferentes franjas de atención a la ciudadanía. Asimismo, es la herramienta sobre la que se estructura y coordina las diferentes actividades/tareas que deben desempeñar los/las profesionales de los Centros de Servicios Sociales, en base a los objetivos de trabajo y las prioridades marcadas por la organización.

El análisis de las agendas de atención pone de manifiesto los siguientes problemas:

- Existen diferentes agendas de atención en el turno de mañana y el de tarde: en estructura, distribución de tiempos, número de citas...
- Es necesario establecer mecanismos que optimicen las citas de los/las profesionales, dado el elevado número de personas que no acuden a su cita.
- Los criterios de gestión de las agendas son heterogéneos: atención a urgencias, gestión de suplencias, citas imprevistas, reserva de huecos para casos nuevos...

7.3.6.- LA ATENCIÓN GRUPAL.

El modelo organizativo de los CSS da prioridad a la atención individual, sobre otros modelos de intervención social, como son el grupal o comunitario. Los resultados de los distritos que han desarrollado esta práctica demuestran a través de encuestas de satisfacción, que tanto personas usuarias como profesionales la interpretan en clave de agilidad, es motivadora para gran parte de profesionales y aporta satisfacción a gran parte de las personas atendidas.

Los aspectos a destacar a partir del análisis de esta área de mejora son los siguientes:

- La intervención grupal carece de un marco que garantice una metodología y organización homogénea en los 21 distritos, estando más instalada en la UTS de Zona.
- La intervención grupal en la UTS de PA es muy desigual y minoritaria. La practican de forma sistemática y con criterios definidos y compartidos dos distritos.
- Desigual participación y experiencia en intervención grupal de los profesionales. Hay trabajadores/as sociales en las UTS que no han realizado intervención grupal nunca, mientras otros mantienen grupos de forma prolongada.
- El equipo de profesionales de forma mayoritaria identifica con mayor valor hacia la ciudadanía y mejores resultados, la práctica de la atención individual sobre la grupal, en ocasiones justificándolo por ser una atención social centrada en la persona

.

7.3.7.- LA FORMACIÓN.

La formación es un derecho y un deber individual del empleado público que contribuye a mejorar el rendimiento de los recursos humanos que desempeñan su actividad en la Administración Municipal (Plan de Formación del Ayuntamiento de Madrid 2017).

La ampliación y mejora de la oferta formativa debe estar orientada al desarrollo y actualización de las competencias profesionales y la cualificación específica de los diferentes colectivos que integran la red de Atención Social Primaria. El desarrollo de capacidades y el aprendizaje de nuevos conocimientos tienen un impacto directo en la calidad de los servicios prestados.

Los problemas identificados respecto a formación dirigida a profesionales de la red de Atención Social Primaria son los siguientes:

- Escasa participación de los potenciales destinatarios en la programación.
- El grupo de POSI no cuenta con formación específica, a pesar de que, en muchos casos, son los primeros profesionales que atienden a las personas que acuden a los Centros de Servicios Sociales.
- Falta de coordinación entre los departamentos del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo a la hora de realizar sus propuestas formativas, tanto en la temática como en la calendarización.
- Percepción de las personas trabajadoras de una oferta formativa insuficiente.

7.3.8.- LA HOMOGENEIDAD ORGANIZATIVA.

El territorio, las realidades sociales y las dinámicas del entorno de la Ciudad de Madrid, son diversas y cambiantes, sin embargo, la respuesta del Ayuntamiento ante todas estas variables debe de estar compuesta por elementos de la misma naturaleza, o al menos semejantes, integrados en una estructura organizativa uniforme, capaz de garantizar la igualdad en el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos.

El entorno operativo ha evolucionado desde que se fijaron los criterios organizativos de la ASP en 1998, pero no por ello dejan de estar vigentes las líneas generales que se marcaron en aquel contexto. Hay muchas desviaciones sobre el modelo original, pero también hay muchos criterios que perduran, que han servido y siguen siendo la base para evaluar, y que sólo requieren de pequeños ajustes.

Los equipos de trabajo han ido adaptando el modelo organizativo a la disponibilidad de recursos personales en aras a rentabilizar los mismos y ser más eficientes, pero esta práctica no siempre ha cumplido su objetivo inicial, sino que ha provocado un sistema desigual en el acceso de la ciudadanía a la red de ASP y ha derivado también, en desigualdad de cargas de trabajo de profesionales que tienen un mismo puesto y, por lo tanto, idénticas funciones y tareas a desarrollar.

7.3.9.- LOS APLICATIVOS DE GESTIÓN.

La gestión de los Servicios Sociales de Atención Social Primaria, compuesta por una red de 36 Centros de Servicios Sociales y dos Puntos de Atención, con 836 profesionales, en la que se trabaja con alrededor de 200.000 familias, de las que más del 50% son beneficiarias de algún servicio público, y donde el volumen de tramitaciones anuales supera el medio millón de procesos, cada uno de ellos con sus correspondientes procedimientos, requiere de un potente aplicativo de gestión integral y con capacidad para integrar a todos los agentes que intervienen en la red de atención.

El sistema de gestión de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid pivota en el aplicativo CIVIS, desarrollado por la propia organización. A las labores propias de mantenimiento y actualización de los procedimientos, se requiere incorporar nuevas funcionalidades que ayuden en la simplificación de los procesos de trabajo, faciliten la labor de los profesionales, acerquen los servicios sociales a la ciudadanía, y generen información inmediata y veraz de cara a la planificación de los servicios sociales y a la publicación de datos abiertos; en definitiva, un aplicativo que ayude a caminar hacia unos servicios sociales modernos, accesibles, transparentes y eficientes.

8.- INSTRUCCIÓN 1/2.018 SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

La función principal de los Centros de Servicios Sociales ((CCSSSS), como equipamiento básico de la Atención Social Primaria, es **garantizar la atención social a la ciudadanía en los 21 distritos del municipio.**

La organización del trabajo en los CCSSSS se regula mediante los siguientes instrumentos:

- **Modelo de atención en Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid de 1.998.**
- **Instrucción 2/2.006 sobre criterios básicos para el mantenimiento de la atención en los Centros de Servicios Sociales.**
- **Instrucción 1/2.007 sobre actualización de criterios para la atención en la Unidad de Primera Atención de los Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid.**
- **Instrucción 1/2.014 sobre la organización de la atención en los Centros de Servicios Sociales en horario de tarde.**

(Estas Instrucciones quedan sin efecto con la Instrucción 1/2.018, excepto el apartado 1 de la Instrucción 1/2.014).

El sistema actual de atención en los CCSSSS, si bien en líneas generales resulta adecuado, presenta algunas disfunciones cuya corrección se pretende con la aprobación de la presente instrucción.

Se pretende una revisión de los criterios organizativos, con la intención de conseguir una mayor eficiencia en la atención social, así como la equiparación de las/los profesionales del turno de mañana y tarde, en cuanto a días de atención, franjas horarias y duración de las entrevistas.

El **Plan de Mejora de los CCSSSS del Ayuntamiento de Madrid de 2.017** recoge una serie de acciones encaminadas a minimizar los problemas detectados mediante la redefinición, entre otros, de la estructura de las agendas profesionales, como instrumento clave para organizar y garantizar la homogeneidad de la atención social, tanto a nivel territorial como en las diferentes franjas de atención a la ciudadanía.

8.1.- CRITERIOS GENERALES SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN SOCIAL.

Se mantiene el modelo organizativo de 1.998, según el cual la intervención social en los CCSSSS del Ayuntamiento de Madrid se instrumentaliza a través de la UTS que, a su vez, se divide en Primera Atención (PA) y Zona.

- Como criterio general, cada TS quedará adscrito, **bien a la UTS de PA, bien a la UTS de Zona.**
- Las/os TS dispondrán de una **agenda**, en la que se registrarán todas las citas semanales (individuales o grupales) de las personas a atender. La composición de cada agenda, en cuanto a días de atención, franja horaria y tiempo de duración de las entrevistas, estará en función de la adscripción del profesional a la UTS de PA o de Zona.

La ciudadanía podrá elegir el turno en el que desea ser atendida. No obstante, dada la menor capacidad de atención del turno de tarde, como consecuencia de una inferior dotación de la plantilla, la Dirección del centro, de conformidad con la Jefatura de Departamento de Servicios Sociales, podrá determinar la distribución del volumen de atención entre ambos turnos de trabajo. Para ello, se seguirán criterios de volumen de carga de trabajo por profesional de atención y demandas ciudadanas particulares, debidamente fundamentadas.

La **atención al público**, tanto presencial como telefónica, será diaria, **de lunes a viernes**, y abarcará la **franja horaria** comprendida:

- Entre las **9.00 y las 13.30 horas para el turno de mañana** y
- Entre las **15.00 y las 19.30 horas para el turno de tarde.**

La **actividad profesional** se estructura en dos bloques:

Atención con cita previa (individual o grupal).	Se concreta en las agendas profesionales, tanto de PA como de Zona.
Atención y gestión profesional.	. Visitas a domicilio, que tendrán carácter prioritario. . Atención a la ciudadanía en el CSS. . Coordinación interna: reuniones de equipo, proyectos de distrito … . Coordinación externa: equipo de trabajo de menores y familia, coordinación socio-sanitaria, proyectos comunitarios … . Tramitación y gestión de servicios y prestaciones sociales. . Cualquier otra relacionada con la intervención social.

8.2.- ORGANIZACIÓN DE LA UTS DE PA.

- La/el profesional atenderá en el CSS, **mediante cita previa, cuatro días en semana**. Dos de ellos serán los martes y jueves.

  Cada CSS podrá elegir los otros dos días de atención entre el lunes, miércoles y viernes, garantizando, en la medida de lo posible, la PA todos los días de la semana.
- La atención **con cita previa** se realizará entre la franja horaria comprendida **entre las 9.00 y las 13.30 horas, para el turno de mañana, y entre las 15.00 horas y las 19:30 horas, para el turno de tarde.**
- **Las citas individuales tendrán una duración de 20 minutos.**
- Se programarán **11 citas individuales por día de atención.** Los CSS dispondrán de dos citas individuales / día de atención, que no se ofertarán al Servicio de Cita Previa.
- La **actividad grupal** se programará en una horquilla horaria de **2 horas y 10 minutos**, dentro de la franja horaria de atención.
- En los días de atención en que confluyan citas individuales y actividad grupal, la ratio queda establecida en una actividad grupal y 5 citas individuales.

- En los días no destinados a atención presencial se realizarán las tareas de Atención y Gestión Profesional, **priorizando las visitas domiciliarias** y dentro de estas la **elaboración de los informes sociales contemplados en el Decreto 54/2.015** (que regula el procedimiento para reconocer la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid).

8.3.- ORGANIZACIÓN DE LA UTS DE ZONA.

- La/el profesional atenderá en el CSS, **mediante cita previa, tres días en semana: lunes, miércoles y viernes.**
- La **atención con cita previa** se realizará en la franja horaria comprendida **entre las 9.00 y las 13.30 horas, para el turno de mañana, y entre las 15.00 y las 19.30 horas, para el turno de tarde.**
- **Las citas individuales tendrán una duración de 30 minutos.**
- Se atenderán **8 citas individuales** por día de atención. Los CSSSS dispondrán de dos citas individuales / día de atención, que no se ofertará al Servicio de Cita Previa. En estos huecos se dará prioridad a las personas procedentes de PA.
- La **actividad grupal** se programará en una horquilla horaria de **2 horas**, dentro de la franja horaria de atención.
- Los días de atención en que confluyan citas individuales y actividad grupal, la ratio queda establecida en una actividad grupal y 4 citas individuales.

8.4.- ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD GRUPAL.

- Los CSS organizarán, al menos **dos grupos informativos coordinados por una/un TS de PA, con periodicidad semanal.** Uno de los grupos girará en torno a servicios y prestaciones para personas mayores, y el otro estará relacionado con prestaciones económicas. No obstante, en función de las necesidades, se podrán organizar otros grupos con temas de interés general.
- Igualmente, los CSS organizarán **grupos de intervención social coordinados por las/los TS de UTS de Zona.**
- La Dirección del CSS establecerá, de conformidad con la Jefatura de Departamento de Servicios Sociales, los días de la semana y turno de trabajo en el que se realizarán los grupos. Esta actividad profesional se desarrollará dentro de la franja horaria de atención con cita previa.

8.5.- CRITERIOS ORGANIZATIVOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES EN SITUACIONES EXCEPCIONALES.

8.5.1.- URGENCIAS.

- Los **casos de urgencia**, **sin expediente en el CSS** serán atendidos **por las/los TS de la UTS de PA**, de forma alternativa, en su caso.
- Los **casos de urgencia, con expediente de alta en la UTS de Zona**, serán atendidas por su profesional de referencia.
- La Dirección del CSS, de conformidad con la Jefatura de Departamento de Servicios Sociales, elaborará un cuadrante mensual integrado por todos los/las TS del CSS, que garantice la atención de urgencias ante la ausencia del profesional correspondiente, ya sea de PA o de Zona.

8.5.2.- SUPLENCIAS.

- Toda ausencia de las/los TS será suplida de forma rotatoria con todos las/los TS del CSS, dentro de cada turno de trabajo, y de acuerdo a criterios de proporcionalidad; sin perjuicio de las actuaciones que desde la Coordinación del Distrito deban realizarse ante la Gerencia de la Ciudad.
- La Dirección del Centro tendrá previsto el calendario de sustituciones, de manera que siempre se pueda sustituir al profesional ausente. El calendario de sustituciones complementará la actividad profesional programada.
- Al objeto de garantizar la atención a la ciudadanía, siempre y cuando la dotación de personal lo permita, se fija la permanencia en el CSS de al menos 1/3 de la plantilla, proporcional a cada UTS (PA y Zona).
- Se priorizará la atención de los casos nuevos sobre aquellos que están en seguimiento/intervención social. En el caso de que, por circunstancias sobrevenidas con previsión de duración en el tiempo, en un CSS sólo se dispusiera de un TS, éste pasará a ocuparse de la UTS de PA.

Bibliografía

. Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid.
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM1989_6.pdf?idNormativa=8d6e9d2e3fd4f010VgnVCM1000009b25680aRCRD&nombreFichero=ANM1989_6&cacheKey=5

. Criterios organizativos para la mejora de la atención social.

- Un modelo para la calidad en la atención social.
  https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServALaCiudadania/SSociales/Publicaciones/CriteriosOrganizativosParaMejora/TrabSocialZona01.pdf
- Desarrollo del modelo de atención.
  https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServALaCiudadania/SSociales/Publicaciones/CriteriosOrganizativosParaMejora/TrabSocialZona02.pdf

. Plan de Atención Social Primaria, 2.008-2.011.
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServALaCiudadania/SSociales/Publicaciones/PlanAtencionSocialPrimaria/Plan%20Atencion%20Social%20Primaria.pdf

. Plan de Mejora de los Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid.
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServSocialesYAtencionDependencia/Intranet/Comunicaci%C3%B3nEventos/Jornada%20Mejorando%20la%20ASP/Ficheros/PLAN_DE_MEJORA.pdf

. Análisis y debate sobre los servicios sociales en la Ciudad de Madrid (Jornada de 16 de mayo de 2.018). "Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Madrid: ¿qué modelo necesitamos para el futuro?".
https://www.fresnoconsulting.es/upload/77/87/fresno_Modelo_SerSoc_draft_final__2jul2018_.pdf

. Instrucción 1/2.018 sobre la organización de la atención en los Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid.